

03 - 03- Grossesse extra utérine - Pr. Soummani

Le cours est intitulé « Grossesse extra-utérine ». Qu'est-ce que ça veut dire la grossesse extra-utérine ? Ça veut dire tout simplement que c'est une grossesse qui se développe et qui évolue en dehors de la cavité de l'utérus. Elle est également appelée grossesse ectopique. C'est une pathologie assez fréquente et c'est une pathologie qui, si elle n'est pas traitée à temps, peut entraîner des complications qui peuvent être parfois mortelles.

C'est l'implantation ectopique de l'œuf en dehors de la cavité de l'utérus. Toute grossesse qui se développe en dehors de la cavité de l'utérus est appelée grossesse ectopique ou grossesse extra-utérine. La localisation la plus fréquente, c'est la 30.

Donc la grossesse tubaire, c'est la pathologie la plus fréquente de cette pathologie. En général, c'est une pathologie qui devient de plus en plus fréquente vu que la principale étiologie est l'infection sexuellement transmise. Donc plus on a d'infections sexuellement transmises, plus on a de grossesse ectopique.

Si vous faites le diagnostic assez tôt, vous pouvez traiter en préservant la 30. C'est-à-dire vous pouvez ne pas enlever toute la 30 parce que parfois on est amené à enlever toute la 30. Parfois même on peut traiter médicalement.

Donc ça n'évolue pas toujours vers une complication à condition que vous traitez assez tôt. Actuellement, toute grossesse ectopique, si elle nécessite un traitement chirurgical, ça doit être un traitement par hystérectomie. Donc sauf exception, on fait une laparotomie, quelques rares cas.

Si la maladie n'est pas diagnostiquée à temps, vous pouvez avoir le pronostic vital qui est mis en jeu. Donc on peut avoir le décès de la femme actuellement puisqu'on diagnostique assez tôt la grossesse ectopique et par conséquent le pronostic n'est plus lié au décès, n'est plus un pronostic vital, mais c'est surtout un pronostic de fertilité. Est-ce que la femme peut avoir des enfants après ou non ? C'est ça le vrai pronostic actuel.

Avant, lorsque j'étais à votre place, on nous dit toujours que si c'est une grossesse extra-utérine, faites attention, la femme va mourir. Actuellement, on voit rarement des cas, sauf les cas qui sont loin, qui n'ont pas l'accès aux soins, mais en général on ne voit plus ces complications qui sont mortelles. Bon, voilà quelques objectifs, vous allez les trouver.

Voilà un peu d'épidémiologie. Donc ça varie en fonction des régions. C'est entre 1,5 et 2 % des grossesses.

Donc vous voyez, c'est assez fréquent. 100 grossesses, 2 grossesses extra-utérines. Chez nous, par exemple, on fait 40 accouchements, donc 80 grossesses, 1, quelques grossesses extra-utérines.

En France, c'est 14 000 cas par an. Et l'âge maternel, en général, c'est plus on avance dans l'âge, plus il y a risque de grossesse extra-utérine. Donc il y a un petit pic avant 21 ans qui disparaît, puis il va réaugmenter.

Au-delà de 40 ans, on a 6 % des grossesses extra-utérines. Donc plus on avance dans l'âge, plus la grossesse extra-utérine devient plus fréquente. Voilà un peu.

Il y a ici un pic, le voilà. Ce pic, en général, est dû au fait que c'est les premiers rapports sexuels. Chez l'adolescente, ça c'est danois, c'est pas marocain.

Je ne sais pas, au Maroc, est-ce qu'on commence à 15 ans, 14 ans ou non, ou pas encore, ça peut venir. Mais on a un pic parce que les adolescentes sont exposées à des infections sexuellement transmissibles parce qu'elles ne se protègent pas. Elles n'ont même pas la notion de se protéger, elles sont jeunes.

Mais c'est surtout après l'âge de 40 ans où on voit que la fréquence augmente jusqu'à presque 7 % après 40 ans. Les étiologies, il y a deux types d'étiologies. Il y a la GU maladie, la grossesse extra-utérine maladie, et la grossesse extra-utérine accident.

La grossesse extra-utérine maladie, ça veut dire que c'est une pathologie qui a tendance à récidiver parce que la trompe est de mauvaise qualité. Donc les lésions tubaires, il y a les lésions tubaires qui sont congénitales et les lésions tubaires secondaires, c'est-à-dire acquises. C'est le cas des infections sexuellement transmissibles.

Et surtout, vous n'entendez pas. C'est bon, il y a des places vides devant. Si vous voulez, vous passez ici.

Parce que c'est ce que j'ai, j'ai pas autre chose. Celui-là est meilleur? Oui, oui, oui. Donc je disais qu'il y a la grossesse extra-utérine maladie qui a tendance à récidiver.

Elle survient sur une trompe pathologique. La lésion peut être acquise ou peut être congénitale, mais le plus souvent acquise, c'est une infection sexuellement transmise telle qu'il y a la plus fréquente, c'est la salpingite chronique à chlamydia. Le chlamydia, il entraîne beaucoup de dégâts au niveau des trompes.

Donc ça, c'est la grossesse extra-utérine maladie. Et il y a la grossesse extra-utérine qui est accident. En général, ce type de GU sont des GU qui ne récidivent pas ou récidivent rarement.

Ces accidents, ça veut dire qu'il y avait au moment de la fécondation, il y avait un événement qui va entraîner l'arrêt de la migration de l'œuf vers la cavité de l'utérus. Il va rester au niveau de la trompe. Donc soit un retard de la pente ovulaire, un asynchronisme hormonal.

Vous savez que la progestérone a tendance à favoriser la migration de l'œuf vers l'utérus, alors que les œstrogènes jouent l'effet inverse par les mouvements des cils vibratiles au niveau de la

trempe. Au niveau de l'onde dothélium tuber, il y a des cils vibratiles sous l'effet des hormones. Il peut faire les mouvements vers le dedans ou vers le dehors.

Si c'est vers le dedans, il va favoriser la migration de l'œuf vers le dehors. Ça va rester en dehors de la cavité de l'utérus. Il y a également le retard de la captation de l'œuf.

Une fois que l'œuf est fécondé, la formation de l'œuf commence à se multiplier. Lorsqu'il se multiplie, elle va augmenter de volume. Au niveau de la trempe, il y a les franges tuber.

Au niveau du pavillon tuber, il y a des franges qui ont le rôle d'aller capter l'œuf pour qu'elle rentre dans la trempe et migre vers l'utérus, vers la cavité. Si cette captation de l'œuf survient tardivement, l'œuf va être plus volumineux que le pavillon de la trempe et par conséquent, il va faire sanitation en dehors de la cavité de l'utérus. Troisièmement, anomalies de transfert.

C'est ce que je vous ai dit. Il y a un problème au niveau de la trempe, surtout au niveau des cils vibratiles, qui va laisser l'œuf au niveau de la trempe et qui va empêcher l'œuf d'arriver au niveau de la cavité de l'utérus. C'est la différence entre grossesse extra-utérine maladie et grossesse extra-utérine accident.

Les facteurs de risque. La première des choses, c'est les cicatrices au niveau de la trempe. Le plus souvent, ce sont des cicatrices qui sont dues à une infection ancienne.

La trempe s'infecte, c'est la salpingite, ce qu'on appelle la salpingite. Elle va guérir, le processus infectieux va disparaître, mais il va laisser des séquelles, de la fibrose. Une cicatrice au niveau de la trempe ne va pas disparaître et peut causer la grossesse extra-utérine.

Il y a également les antécédents de la grossesse extra-utérine. C'est-à-dire, vous avez une femme qui vient pour une grossesse extra-utérine, vous l'avez traitée et vous avez conservé la trempe. Mais en conservant la trempe, cette trempe ne va pas être de bonne qualité parce qu'elle était siège d'une grossesse.

Donc, il y aura une cicatrice, il y aura de la fibrose et elle va être sujette à une grossesse extra-utérine ultérieurement. Il y a également l'endométriose tuber, ce qu'on a vu l'autre fois, et il y a la chirurgie tuber. Il y a des femmes, c'était avant, maintenant on ne le fait pas.

Avant, lorsque la femme a des problèmes au niveau de la trempe, on intervient chirurgicalement pour régler le problème anatomiquement. Mais en faisant ça, on entraîne des lésions au niveau de la trempe qui vont cicatriser et par conséquent, la chirurgie tuber constitue une étiologie à la grossesse extra-utérine. Il y a également le synchronisme hormonal.

Ça, c'est l'accident, c'est la grossesse extra-utérine, l'accident. C'est la première, c'est la pilule, surtout la pilule micro-dosée parce que les micro-progestatifs jouent un rôle en inversant les mouvements des cils vibratiles. Au lieu qu'ils vont de dehors vers le dedans, sous l'effet hormonal, ils vont faire l'inverse et par conséquent, au lieu de favoriser la migration de l'œuf vers

la cavité de l'utérus, ils vont empêcher cet oeuf de partir vers la cavité de l'utérus.

Il y a également les inducteurs de l'ovulation. Les inducteurs, c'est tous les médicaments qu'on donne à la femme pour induire une ovulation. Il y en a plusieurs.

Le plus important, c'est la FSH. On donne à la femme la FSH pour qu'on multiplie la croissance folliculaire, mais ces inducteurs de l'ovulation peuvent entraîner une grossesse extra-utérine. Il y a également les malformations congénitales des trompes et il y a d'autres, par exemple, la fécondation in vitro.

Peut-être, lorsqu'on fait le transfert de l'embryon dans la cavité de l'utérus, vous connaissez comment ça se passe la fécondation in vitro, ça se fait au niveau du laboratoire, ils nous donnent des embryons qu'on va mettre au niveau de l'utérus. Mais il doit subir des règles. Sinon, vous allez injecter un peu trop, vous allez pousser les embryons au lieu qu'ils restent au niveau de la cavité, ils peuvent partir à travers l'ostium tubaire vers les trompes et ainsi favoriser la grossesse extra-utérine.

Il y a le dispositif intra-utérin, le stérilet. Tout le monde le connaît, le stérilet, il est au niveau de la cavité. Il va entraîner une petite inflammation et il peut empêcher l'implantation de l'oeuf au niveau de la cavité de l'utérus.

Et il y a, point d'interrogation, le tabagisme, qui est incriminé dans les facteurs de risque de la maladie. Les localisations, il y en a plusieurs. La localisation, la grossesse ectopique en général, c'est surtout au niveau de la trompe.

Les grossesses tubaires, c'est les plus importantes. Au niveau de la trompe, c'est la plus importante, la plus fréquente. Au niveau de la trompe, la grossesse ovulaire est également la localisation la plus fréquente.

C'est pratiquement 80% des grossesses extra-utérines, c'est des grossesses ovulaires. Il y a la grossesse isthmique, c'est au niveau de l'isthme de la trompe. Il y a la grossesse pavillonnaire, c'est-à-dire au niveau des franges du pavillon tubaire.

Il y a la grossesse extra-utérine cornuale, au niveau des cornes de l'utérus, abdominale, au niveau de l'abdomen. La grossesse ovarienne, c'est-à-dire au niveau de l'ovaire, et la grossesse cervicale, en cas particulier, c'est très, très rare, les autres, mais c'est surtout la grossesse tubaire qui est la plus fréquente. Voilà un peu les différentes localisations de la grossesse extra-utérine.

La grossesse extra-utérine isthmique, c'est là, c'est au niveau de l'isthme. Elle a la particularité, cette grossesse isthmique, d'évoluer rapidement vers la rupture de la trompe. Vous connaissez, si vous vous rappelez de l'anatomie, que la structure de la trompe, au niveau de l'isthme, est caractérisée par le fait que la lumière tubaire est trop étroite, et puis la musculature est plus importante que la muqueuse, et par conséquent, elle est peu extensible.

Dès que l'œuf commence à augmenter de volume, elle entraîne sa rupture. Deuxième chose, c'est qu'au niveau de l'isme, c'est là en général, là il y a l'arrivée de trois troncs vasculaires, le tronc tuber, le tronc sous-tuber et le tronc de l'artère utérine, donc à proximité. Donc ici, la bifurcation de plusieurs vaisseaux, et lorsque la treme se rompt, elle va rompre avec elle ses vaisseaux, et par conséquent, on aura une hémorragie abdominale très importante, qui peut entraîner l'état de choc.

Donc ça, c'est la caractéristique de la grossesse ismique. La grossesse abdominale, ça se développe en général au niveau de l'abdomen, donc il y a plusieurs, et il y a de l'espace, donc il peut évoluer jusqu'à même sept, huit mois, même plus. Le problème, c'est que le placenta va prendre sa vascularisation de l'aorte abdominale, et elle va donner les veines vers la veine cave inférieure.

C'est des gros vaisseaux, si vous voulez enlever la treme, vous allez arracher ces gros vaisseaux de l'abdomen, et ça entraîne rapidement la mort de la femme. Et pour ça, on n'enlève pas le placenta lorsqu'on est devant une grossesse abdominale. Bon, quoi encore ? Pour le reste, c'est simple, ça peut évoluer.

La grossesse interstitielle, c'est là, c'est la grossesse cornuelle, également appelée la grossesse cornuelle, elle a le même pronostic que la grossesse ismique. Il y a la grossesse cervicale qui se développe au niveau de la paroi du col utérin, et en général, elle entraîne la rupture du col de l'utérus. Voilà un peu les différents types de localisation de la treme.

Comment va évoluer la grossesse extra-utérine ? Nous avons dit que la fécondation en général se fait à l'extérieur de la treme ou bien au niveau du tiers externe de la treme, puis il y a la migration, elle va être captée par le pavillon tuber, et elle va être orientée vers la cavité de l'utérus. Là, à cause des facteurs de risque qu'on a vus, elle va s'implanter au niveau de la treme. Lorsqu'elle va s'implanter au niveau de la treme, elle va augmenter de volume, mais la treme n'est pas le lieu propice pour l'anidation.

Donc, vous aurez deux choses, soit elle va augmenter de volume jusqu'à ce qu'elle entraîne une rupture de la treme, soit elle va connaître le sort d'une grossesse arrêtée. Elle va s'arrêter parce qu'il n'y a pas de vascularisation, elle va être clivée et elle peut être chassée vers l'abdomen ou bien chassée vers la cavité de l'utérus par la suite et disparaître. Donc, le plus souvent, heureusement que ça disparaît.

Donc, il y a le décollement et l'expulsion de l'œuf qui est développé dans la treme. Donc, s'il est avorté au niveau de l'abdomen, on parle d'avortement tubo-abdominal. S'il se fait vers l'utérus, ça s'appelle avortement tubo-utérin.

En général, s'il se fait, elle va être comme une fausse couche. Mais le plus souvent, elle va augmenter de volume et elle va entraîner la rupture de la treme. Dans ce cas, elle va entraîner

un hémopéritoire plus ou moins important qu'on va voir dans le chapitre complications.

Et le cas particulier de grossesse abdominale, je vous ai parlé de ça. Donc, on va prendre comme type de description une grossesse extra-utérine-tubaire. Bon, c'est une femme en période d'activité génitale parce qu'elle est enceinte.

Une femme en période d'activité génitale qui a un terrain particulier. Soit tabagique, soit elle a fait beaucoup d'infections sexuellement transmissibles, soit elle est endue. Donc, tout facteur de risque qu'on a vu peut constituer un terrain favorable à la grossesse extra-utérine.

Cette femme qui est en période d'activité génitale, qui a un terrain particulier, mais faites attention, si la femme n'a pas de problème de facteur de risque, ça ne veut pas dire qu'elle ne fait pas une grossesse extra-utérine parce qu'on a parlé de grossesse extra-utérine accident. La femme n'a rien, n'a jamais fait un passé quelconque et elle fait une grossesse extra-utérine. Donc, qui va consulter pour des signes fonctionnels.

Les signes fonctionnels, en général, il y a trois signes fonctionnels qui sont importants à connaître. Premièrement, il y a le premier, c'est le retard de règle. C'est une femme qui a un retard de règle puisqu'elle est enceinte.

Mais faites attention, parce que toutes les femmes n'ont pas de retard. Pourquoi ? Parce qu'il se trouve que le jour même des règles, elle saigne. Elle saigne à cause de la GU.

Elle prend ce saignement comme ses règles. Donc, si vous allez lui demander est-ce qu'elle a ses règles et est-ce qu'elle a un retard de règle, elle va vous dire non, je n'ai pas de retard, je viens d'avoir mes règles. Alors que ce n'était pas des règles, c'était un saignement.

Nous allons voir qu'il y a les métrorragies. Donc, retard de règle et puis il y a les douleurs pelviennes. C'est en général des douleurs pelviennes qui ont une intensité qui varie d'une femme à l'autre.

Donc, ce n'est pas toujours une douleur, un coup de poignard, ça peut être des douleurs qui sont légères, ça peut être des douleurs qui sont importantes. Donc, c'est une intensité variable. Elles peuvent être discrètes comme elles peuvent être syncopales, vous voyez, qui entraînent une syncope.

C'est des douleurs qui sont intermittentes, mais avec des paroxysmes. Et en général, il irradie vers l'abdomen et il irradie vers la région scapulaire droite. En général, une femme en période d'activité génitale qui a des douleurs qui irradient vers la région scapulaire droite, c'est très, très évocatrice de la grossesse extra-utérine.

Parce qu'il y a un hémopéritoine, donc il y a une irritation péritoniale, l'irritation péritoniale entraîne des douleurs de l'abdomen qui irradient vers l'homoplate. Donc, premièrement, c'est le retard de règles. Deuxièmement, c'est la douleur péelvienne.

Troisièmement, c'est les métrorragies. Les métrorragies, c'est un saignement en dehors des règles. Les métrorragies de la grossesse extra-utérine, c'est des métrorragies qui sont noirâtres.

Pourquoi noirâtres ? Parce que c'est du sang qui a séjourné au niveau de la trome. Lorsque le sang séjourne, quelle que soit la localisation, elle devient noirâtre à cause de la sédimentation. Donc, c'est du sang qui est noirâtre et c'est un saignement de petits morceaux de petits volumes.

Ce ne sont pas des métrorragies abondantes. Vous aurez une femme qui a un retard de règles et qui a des métrorragies qui ont des douleurs péviennees. Donc, le plus souvent, c'est des métrorragies qui sont noirâtres.

On les appelle également les règles. C'est des métrorragies sépia. Vous connaissez sépia ? C'est ça la couleur sépia.

C'est en général très caractéristique et puis de petits volumes parce que c'est un petit volume au niveau de la trome. Ce n'est pas un saignement important. Et s'il y a un saignement important, ça ne se fait pas vers l'utérus, ça se fait vers l'abdomen.

Donc, il constitue un hémopéritoire. Vous aurez un tableau clinique, typiquement une femme qui n'est pas bien, qui est en mauvais état général, une femme qui a des douleurs, qui se torde parfois des douleurs, qui a une chute tensionnelle, qui a de la pâleur, qui a un tachycardie, mais le volume des métrorragies est faible. Il n'explique pas le tableau hémodynamique de la femme.

C'est une discordance entre la perte du sang et l'état hémodynamique de la femme. Pourquoi tout ça ? Parce que cette femme saigne, elle est saine à l'intérieur et non pas à l'extérieur. C'est ça qui va vous permettre de rapidement penser à la grossesse extra-utérine.

C'est une différence importante qui sort aux yeux. Une femme qui n'est pas à l'aise, mais à côté il y a un petit saignement qui ne peut pas expliquer cet état. Donc ça, ça fait partie des choses que vous devez retenir, c'est important.

Mais il faut faire attention, malheureusement la médecine n'est pas une science exacte, c'est pas un plus un égal deux, je le dis toujours. Parfois, tu as une femme qui a des métrorragies qui sont abondantes. Ces métrorragies ne sont pas dues au saignement de la grossesse extra-utérine, mais elles sont dues à l'évacuation, l'élimination de la caduque.

Vous connaissez ce que c'est que la caduque ? Non. Je sais, vous n'avez pas encore fait l'œuf. Une fois la femme enceinte, l'endomètre se développe.

Il devient épais parce qu'il est préparé à recevoir l'œuf pour l'anidation. Vous voyez, jusqu'à maintenant, c'est bon. L'œuf n'arrive pas au niveau de la cavité de l'utérus.

Elle va rester au niveau de la trome. Une fois que la grossesse est décollée, il y a un arrêt de la

grossesse. Lorsqu'il y a un arrêt de la grossesse, l'endomètre va chuter.

Il est très épais. Une fois qu'il chute, il est éliminé et vous aurez des métrorragies abondantes et rougeâtres et panorâtres qui sont dues à la caduque. C'est cet endomètre qui n'a pas reçu de grossesse et qui va disparaître.

Ça, c'est la caduque. Donc, il va chuter et donner l'impression que c'est des métrorragies, comme une fausse couche de métrorragie, noire, rougeâtre, abondante, etc. Il y a d'autres signes.

Ce sont des signes indirects, des signes sympathiques de grossesse, c'est-à-dire les nausées, parfois les vomissements, les seins qui sont tendus. Ce sont les premiers signes de la grossesse, tout simplement. Et il y a les signes qui sont, des signes indirects également, qui témoignent de la sévérité du saignement.

Les vertiges, la lipotimie, en général, ce sont des signes de gravité du saignement. Donc, à la clinique, à l'examen, qu'est-ce que vous allez faire ? D'abord, tout l'examen gynécologique, je vous ai dit qu'il doit se faire vessie et rectum vides. Toujours, lorsque vous voulez faire un examen gynéco, il faut que la vessie et le rectum vides, sauf pour le prolapse génital.

Vous allez recevoir le cours du prolapse génital où il ne faut pas examiner vessie et rectum vides. Premièrement, on commence toujours par l'état général, le pot, la tension artérielle, les conjonctives. En général, tension artérielle abaissée, la tachycardie, donc des pots accélérés, et il y a une pâleur cutanéomyqueuse, parfois même de la sueur.

Le spéculum, vous allez mettre votre spéculum, vous allez trouver que le sang provient de la cavité de l'utérus, ce n'est pas une lésion au niveau du vagin ou bien une lésion au niveau du col de l'utérus, mais c'est une lésion, c'est un saignement endocervical. Et vous allez être frappé par le fait que le col de l'utérus est un aspect de col gravidé, le col d'un utérus gravidé. Utérus gravidé, c'est-à-dire l'utérus porteur d'une grossesse.

On l'appelle utérus gravidé. C'est un col qui est hypervascularisé et par conséquent, il va être un peu rougeâtre. Il est fermé.

Il n'y a pas de glaire parce que la femme est enceinte. La glaire, lorsque la femme est enceinte, se développe et devient un bouchon muqueux à l'intérieur. Et parfois, on va voir, le col est latérodévié parce qu'il est comprimé par quelque chose au niveau du cul de sac vaginal.

Contrôle latéral. Il est dévié soit à droite, soit à gauche. Vous allez faire le toucher vaginal.

L'utérus est gravidé. Souvent, il est de taille normale parce qu'il n'est pas concerné par la grossesse. Il n'y a pas de grossesse au niveau de l'utérus.

La taille est normale. Parfois, un peu augmenté de volume parce qu'il y a la vascularisation importante de l'utérus à cause des hormones du trophoblaste, les hormones trophoblastiques.

Mais en général, c'est un utérus de taille normale.

Si vous avez de la chance, vous allez trouver une masse latérohutéline. Ça veut dire que c'est la chose, la grossesse au niveau de la trompe. Il va augmenter de volume.

Vous allez ressentir une masse à côté de l'utérus. C'est la trompe qui est dilatée, qui est remplie du sang, remplie ou bien siège de l'embryon. C'est une masse latérohutéline qui est douloureuse au toucher.

La masse latérohutéline est douloureuse. Vous pouvez la trouver. Bon, de consistance hydrique parce qu'il n'y a que du liquide, pratiquement que du liquide.

Donc, c'est une masse molle et douloureuse. Parfois, vous n'allez rien trouver. Vous allez trouver uniquement un empattement au niveau d'un cul de sac vaginal.

Un cul de sac vaginal qui manque de souplesse. En général, les sacs vaginaux, les sacs vaginaux latéraux sont souples. Dans la grossesse extra-utérine, on trouve le cul de sac vaginal latéral du même côté du développement de la crampe, parce qu'elle est droite ou gauche.

Vous allez trouver qu'il y a un manque de souplesse. C'est ce qu'on appelle la petite quelque chose de Mondo. Mondo, c'est quelqu'un qui a fait de la chirurgie générale.

Dans le temps, il n'y avait pas de gynécologue, neurologue, traumatologue. Il y avait la chirurgie tout simplement. Cette petite quelque chose, tu trouves que ce n'est pas le cul de sac vaginal que tu connais, que tu as fait beaucoup de toucher.

Il y a le manque de souplesse. C'est très important de connaître. Vous n'allez pas le connaître dès le début.

Il faut un peu de temps, mais vous allez arriver à dire non, ça ne va pas bien. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parfois, tu fais le toucher vaginal, mieux encore le toucher rectal, et tu vas trouver le cri de douglas.

Vous avez fait la péritonite, c'est la même chose, parce qu'il y a du sang dans le douglas, dans la cavité de l'abdomen. Le péritoine est irrité, donc ça va entraîner le cri de douglas, que vous connaissez, la même chose que dans la péritonite. Parfois, dès que vous mobilisez l'utérus, en général, l'utérus, lorsqu'on le mobilise, il n'est pas douloureux.

Dans le cas de la grossesse extra-utérine, il devient douloureux. Donc ça, c'est les petites choses qu'on trouve. C'est pour ça que je dis toujours que si tu as de la chance, tu vas trouver une masse latérale utérine.

Ça va vous rendre la vie facile, parce que tu as une masse latérale utérine, tu as une femme qui a des météorologies, du sang noirâtre, peut-être un retard de règles, tu as tout pour dire que c'est

une grossesse extra-utérine. Mais regardons le côté isthémiste. Une femme qui ne connaît pas qu'elle est en retard de règles, qui n'a pas de météorologie, qui n'a que des douleurs pelviennes, et chez qui vous allez faire votre toucher et vous n'allez trouver qu'un petit empattement au niveau d'un cul de sac vaginal.

Vous voyez, ça devient difficile. Si tu as de la chance, tu as le tableau complet, c'est tant mieux. Si tu n'as pas de chance, tu n'as rien en fait que la douleur.

Ou parfois, il n'y a pas de douleur, il n'y a que des météorologies. Mais on verra les formes post-symptomatiques. Donc, qu'est-ce que je vais vous dire jusque-là ? Vous voyez que je suis optimiste, donc je vais vous dire que tout va bien.

Une femme qui a un retard de règles, douleurs pelviennes, météorologie noire, âtre, masse latérale utérine douloureuse, molle, c'est mieux, c'est bien. De l'autre côté, une femme qui n'a pas de retard de règles, qui n'a pas de météorologie, qui n'a que des douleurs pelviennes, l'examen gynécologique est pratiquement normal, sauf un petit empattement. Il faut avoir de l'expérience de 15-20 ans de gynéco pour savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien dans ce cul de sac de doublage.

Et dans ce cas, on rend la chose difficile. Pour vous régler le problème, vous, toute femme en période d'activité génitale qui consulte pour un événement gynécologique, quel que soit, météorologie, retard de règles, douleurs pelviennes, n'importe quel événement gynécologique, pensez à la grossesse extra-utérine. En premier, si vous faites ça, vous ne risquez pas de passer à côté.

Parce que ce que je vous ai dit au début, c'est que si vous faites votre diagnostic tôt, vous n'aurez même pas besoin de traitement chirurgical. Plus vous tardez, plus le pronostic vital est mis en jeu. Pour régler le problème, parce qu'il y a vraiment beaucoup de formes cliniques, chaque fois qu'il y a un événement gynécologique, c'est une femme en période d'activité génitale, c'est une grossesse extra-utérine jusqu'à preuve de contraire.

Tout simplement. Et puis, ce n'est pas quelque chose de très important, on ne va pas demander l'IRM, on ne va pas demander le scanner, on ne va pas demander le transit de grêle ou je ne sais rien, on va demander le dosage des bêtas ACG. Qu'est-ce que c'est l'ACG ? C'est l'hormone chorionique gravidique.

Hormone qui est sécrétée par l'ultrafoblaste dès la fécondation. Dès qu'on a que l'oeuf est fécondé, on a la sécrétion de l'ACG. L'ACG est absent lorsque la femme n'est pas enceinte.

Si vous trouvez de l'ACG, ça veut dire que la femme est enceinte. La base de l'ACG, c'est ce que vous faites, ce que les femmes font pour voir s'elles sont enceintes ou non. C'est le test de grossesse.

Le test de grossesse, ce n'est pas un dosage, c'est la recherche de l'ACG au niveau des urines. Tout simplement. Mais pourquoi ici, je n'ai pas demandé de faire ? Parce que lorsque vous voulez diagnostiquer une grossesse normale, une femme qui va venir vous dire peut-être que je suis enceinte, j'ai un retard de règle, vous allez demander un test urinaire de grossesse.

Tout simplement, il coûte 60 dirhams ou 70 dirhams. Ce n'est pas grave. Mais si vous êtes devant un signe pathologique et que vous voulez le lier à une grossesse, dans ce cas, demandez le dosage plasmatique de bêta-ACG.

Pourquoi bêta-ACG et non pas ACG ? Qui peut me dire pourquoi ? C'est simple. La médecine, c'est comme le foot. Si vous voulez le simplifier, il devient très simple et très bien à pratiquer.

Plus tu le rends compliqué, tu rends la vie de médecin compliquée. L'ACG a les mêmes caractéristiques biochimiques que la LH. La LH, contre la FSH, c'est quoi l'hypothèse d'ACG ? J'en donne un tronc et deux bras.

C'est la même chose. Donc si vous dosez l'ACG, peut-être que vous aurez du mal, ou que le laboratoire aura du mal à distinguer entre la LH et l'ACG. Les caractéristiques biochimiques, c'est la même chose, sauf un seul bras.

Le bras bêta de l'ACG est complètement différent du bras bêta de la LH. C'est pour ça qu'au lieu de doser l'ACG, on ne dose que le bras bêta de l'ACG, qui est différent du bras bêta de la LH. Et par conséquent, on est sûr qu'on dose l'hormone de la grossesse.

Et lorsqu'il est regardé, qu'est-ce que j'ai dit ? Elle se positive un jour après la fécondation. Après la fécondation, 14e, 15e jour du cycle. Donc le 26e jour du cycle, tu as les bêtas ACG qui sont positives.

Avant même les règles. Donc la femme peut connaître qu'elle est enceinte avant qu'elle n'ait son retard de règles. Bon.

11e jour, elle devient positive et elle va doubler chaque 48 heures. 1000, 2000, 4000, 8000, 16000, chaque 48 heures, il double. Bon.

Ici, vous avez demandé un taux de bêta ACG et il va revenir positif. Bon. En ce cas, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la femme est enceinte.

Mais ça ne veut pas dire qu'elle a une grossesse extra-utérine. Ça peut être une grossesse intra-utérine. Tu as pris du sang d'une femme parce qu'elle a des douleurs telviennes.

Tu as trouvé que le taux de bêta ACG est élevé. La femme est enceinte. C'est tout ce que tu as.

C'est une femme enceinte. Mais est-ce que c'est effectivement une GUE ou une grossesse à l'intérieur de l'utérus, on ne peut pas savoir. Mais on peut le faire lorsque l'on étudie la courbe, la

scénétique des bêtas ACG.

Pourquoi ? Parce que la grossesse extra-utérine est une grossesse de mauvaise qualité. Ce n'est pas une grossesse qui a une nidation normale. Le trophoblaste ne va pas se développer correctement.

Donc, il ne va pas sécréter correctement les bêtas ACG. Donc, au lieu qu'il double chaque 48 heures, il ne va pas doubler. Ce n'est pas comme une grossesse normale.

Mais malgré ça, ça ne vous permet pas de dire que c'est une grossesse extra-utérine. Donc, la seule façon de faire... Voilà un peu de quoi il s'agit. Comme ça.

Regardez bien. Ici, on a les règles. Les règles de l'idée sur le crâne.

Le quatorzième jour du cycle, en général, commence la grossesse. La fécondation se fait ici. En général, dès J10, après la fécondation, on a les bêtas ACG qui sont détectables dans le sang.

Donc, on peut les avoir. Donc ici, on peut dire que la femme est enceinte. Par contre, les bêtas ACG urinaires, les tests de grossesse, ne commencent qu'après les règles à venir.

Vous voyez, juste au moment s'il y a un retard de règles, vous n'aurez pas de règle ici et vous aurez les bêtas ACG urinaires qui sont présentes. Donc, je disais que les bêtas ACG seuls ne permettent pas de dire que c'est une grossesse extra-utérine. Sauf s'il est couplé à l'échographie.

En fait, c'est un couple qui va vous permettre de dire est-ce que c'est une grossesse extra-utérine ou non. Si vous voulez, pas si vous voulez, si vous pouvez, faites l'échographie endovaginale. Il va vous donner plus de détails puisque l'échographie endovaginale permet de détecter le sac gestationnel à partir de la cinquième semaine.

Avant la cinquième semaine, vous faites l'échographie endovaginale, vous ne trouvez pas de sac gestationnel. L'utérus est vide. Il est trop petit pour qu'il soit visible à l'échographie.

Comment on fait ? En général, lorsque vous avez un taux de bêta-ACG au-delà de 1500 unités, on doit voir le sac gestationnel par l'échographie. Autrement dit, si tu as un taux de bêta-ACG à 1800 par exemple, et que vous faites votre échographie endovaginale et que vous trouvez un utérus vide, ça veut dire que c'est une femme enceinte et la grossesse est ailleurs. Ça s'appelle le seuil discriminatoire, c'est-à-dire le seuil où vous devez voir le sac gestationnel au niveau de l'utérus.

Donc, bêta-ACG au-delà de 1500, prenez 1500 mieux que 1000 parce que j'avais des problèmes avec 1000. Mais j'ai fait ça exprès parce qu'on ne sait pas toujours comment les laboratoires font, mais on a trouvé pas mal de femmes à 1000 unités avec un utérus vide. On attend un peu, 48 heures ou 72 heures après, on refait l'échographie et on trouve que la femme est enceinte.

C'est pour ça que j'ai décalé un peu à 1500. Donc, si vous êtes à 1500 unités, vous devez voir le sac gestationnel par l'échographie endo-utérine. Si vous ne voyez pas de sac et que vous êtes à 1500, ça veut dire que c'est la grossesse extra-utérine qui est très probable.

Est-ce que vous avez compris? C'est important. Le plus souvent, je pose des questions à ceux qui examinent. Les étudiants qui étudient les deux premières rangées, nous leur disons que nous sommes les internes.

Mais en réalité, pour nous, parce qu'il n'y avait pas ça, le prof était en train de l'écrire au fur et à mesure. Nous ne l'écrivons pas. Mais c'est les internes qui écrivent tout.

Tout ce qu'on a écrit. C'est pas un changement, c'est un changement. Non.

Vous pouvez avoir de la chance, c'est merveilleux, de trouver une image latéro-utérine, hypo-écogène ou anécogène. Le plus souvent il est hypo-écogène et hétérogène. Oui, on parle d'abord de ça.

Parfois vous allez trouver, et ça il ne faut pas le prendre comme une grossesse, vous allez trouver qu'il y a une image lacunaire, hypo-écogène, au centre de l'utérus. Ne prenez pas ça comme un sac gestationnaire. Je vais vous montrer.

Ils n'ont pas de... Bon, je ne sais pas comment faire pour écrire. Ils n'ont rien. Oui, mais j'ai pas... Il n'y a rien.

Un classique. Ah oui, ça, merci. Ah, merci.

Donc, voilà ce que vous allez trouver lorsque vous aurez une... Vous avez... C'est flou. Donc, je vais essayer de le rendre moins flou. C'est toujours flou.

Donc, vous allez voir. Donc, vous aurez une image. Vous aurez l'utérus qui est comme ça, grosso modo.

Et au centre, vous allez trouver la ligne de vacuité et il fait ça. Vous aurez une image au centre et qui est un écogène ou hypo-écogène qui est au centre. Bon, vous pouvez prendre ça comme une grossesse intra-utérine.

Or, ce n'est pas un sac gestationnaire, c'est un pseudo-sac gestationnaire. C'est uniquement du sang au niveau de la cavité de l'utérus. Comment vous allez faire la différence entre les deux, entre un sac gestationnaire intra-utérin et un pseudo-sac intra-utérin ? Tout simplement, regardez le sac gestationnaire, comment il est.

Ici, il est au centre. Ici, il est excentré. Il est partout pour l'utérus, via l'anidation.

Et regardez en plus, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a ce qu'on appelle un halo autour. C'est le

trophoblast autour du sac. Il y a un halo qui n'existe pas au niveau de la cavité.

Il existe uniquement autour, dans la profondeur de l'endommagement. Donc ça, c'est un pseudo-sac gestationnaire et ça, c'est un sac gestationnaire. Si tu as ça, c'est une grossesse intra-utérine.

Si tu as ça, ça veut dire qu'il y a un saignement. Ça ne veut pas dire qu'il y a une gêne. Si tu as ça et tu as un taux de bêta-CG à 1500, ça est une grossesse intra-utérine probablement.

Donc ça, la différence entre le sac gestationnaire et le pseudo-sac gestationnaire. Tout ça, c'est des signes indirects. On n'a pas encore un signe paraclinique direct.

Donc voilà, c'est quoi le pseudo-sac gestationnaire. Le gestationnaire avec L1, MFH2, L1. Donc voilà un peu l'image du pseudo-sac gestationnaire.

Il est centré dans la cavité de l'utérus. Il n'y a pas de courant trophoblastique. À l'opposé du sac gestationnaire qui est intra-utérine, qui est excentré et qui est entouré par la courante trophoblastique.

Est-ce que c'est compris ? On passe. Donc j'ai dit que ça, c'est des signes indirects. On n'a pas une image de la grossesse extra-utérine.

Il y a un autre signe indirect. C'est lorsque vous faites l'échographie, vous allez trouver du sang au niveau du Douglas. Le sang, c'est une image qui est anéchogène, c'est du liquide.

Donc du liquide au niveau du Douglas. Ça, c'est un hémopéritoïde. Ça ne veut pas dire que c'est une GU, mais lorsque tu as un hémopéritoïde, c'est une femme en période d'activité génitale, dans 96% des cas, c'est une grossesse extra-utérine.

Dans 4% des cas, c'est une rupture d'un vaisseau maison-terre ou d'un vaisseau d'un kyste ovarien ou d'un kyste maison-terrique ou paratuber, etc. D'autres idéologies d'hémopéritoïdes. Donc c'est une zone anéchogène, rétro-utérine.

Et si ce sang stagne pendant des jours, vous aurez une image hétérogène parce qu'il caillote. Donc vous n'allez pas trouver une image anéchogène. Ce n'est pas du liquide, c'est des caillots du sang qui sont hétérogènes à l'échographie.

Et puis, ce que je vous ai dit, si vous avez de la chance, vous avez la traduction de la masse latérale utérine. Donc vous aurez une image latérale utérine qui est hétérogène parce que c'est du sang qui est, c'est l'hématosalpins, c'est du sang au niveau de la trempe. Le sang au niveau de la trempe est appelé hématosalpins.

Donc c'est du sang qui a stagné, qui a cailloté. Donc c'est une image latérale utérine qui est hétérogène. Si vous êtes chanceux, mais vraiment chanceux, vous allez trouver une image latérale utérine avec un sac gestationnel, avec un embryon, avec une activité cardiaque positive.

Donc si tu as cette image à l'extérieur de l'utérus, c'est une grossesse extra-utérine, n'est-ce pas? Malheureusement, non. La médecine, la médecine. Malheureusement, non, mais le plus souvent, c'est oui.

Si tu as une masse latérale utérine, il faut opérer la part. Parfois, tu as un utérus qui est bicorné, une grossesse au niveau d'une corne, l'autre corne, il n'y a rien. Donc tu fais l'échographie, tu trouves une corne, vide à côté, un sac gestationnel avec une activité cardiaque, c'est l'embryon au niveau de l'autre corne.

Ce n'est pas une grossesse extra-utérine, c'est une malformation utérine. Mais en général, on ne peut pas savoir ce genre de problème sans résoudre lorsqu'on fait une celluloscopie. Pour nous, lorsque tu as une cavité vide, un sac gestationnel avec activité cardiaque à côté, c'est une grossesse extra-utérine.

On fait la celluloscopie. Lorsqu'on fait la celluloscopie, on va trouver que les trempes, il n'y a rien au niveau des trempes, mais il y a deux cavités, deux utérus, deux cornes de l'utérus. Bon, c'est une grossesse extra-utérine.

Là, réellement, c'est comme ça. Parfois même, il y a des cas où ça devient plus compliqué que tout ça. C'est lorsque tu as une grossesse à l'intérieur de l'utérus et une grossesse à l'extérieur de l'utérus.

Ça arrive. Une grossesse gemellaire, un embryon est arrivé au niveau de la cavité de l'utérus, l'autre a trouvé sa nidation au niveau de la corne. Des cas qui se compliquent tout simplement.

Aujourd'hui, le staff, à 13 heures, ils m'ont expliqué un petit gynécome. Personne. Le gynécome, le décès du vendredi.

Un décès maternel qui était au service. En général, lorsque je fais le staff, la première des choses, c'est les accidents du service. Et il y avait une femme.

Ils m'ont présenté la femme. C'est une femme enceinte de 31 semaines d'aménorrhée qui était hospitalisée pour pyelonephrite gravidique le vendredi. Elle a reçu le ceftriaxone, C3G, les ontalgiques.

C'est une pyelonephrite clépsielle sensible au ceftriaxone. Donc il n'y a pas de problème. Et même la CRP s'est améliorée.

Elle fait une anémie importante à l'entrée CTA7 et puis 5, démo-globine, mégalo-blastique, la vie des hématologues, faire une électrophorèse de protéines. Lorsqu'ils m'ont présenté la femme, j'ai dit non, la pyelonephrite ne peut pas tuer cette femme. La pyelonephrite, oui, elle tue.

Lorsqu'elle est négligée pendant 15 jours, 20 jours, un mois, elle devient en septicémie, puis en état de choc. Mais la femme est hospitalisée, elle a reçu du traitement, elle allait bien, et puis elle

décède. J'ai dit bon, l'hémolyse, qu'est-ce qu'il y a au niveau de l'hémolyse ? À 14h30, avant de venir ici, 15 heures moins quelque chose, c'était une drépanocytose.

L'électrophorese de protéines, c'est une drépanocytose importante qui l'a tuée. J'ai demandé aux hématologues, ils ne font pas l'électrophorese. Donc même si on a le diagnostic avant le décès, on ne peut rien faire pour elle.

Donc vous voyez qu'il y a des choses inévitables. C'est des choses, en général, lorsque tu as ça, ça peut aller jusqu'à la rupture de la tumeur. Parce que tu as les bêtas, c'est gênant, et la grossesse est à l'intérieur de l'utérus.

Donc tu te dis, si la femme a des douleurs importantes, tu lui as donné des antalgiques, ça n'a pas marché, tu veux savoir pourquoi elle a ces douleurs, tu peux penser à des complications, et tu fais une échocytoscopie, mais c'est rare. Donc c'est les cas qui se compliquent qu'on fait des erreurs de diagnostic, parce que ce n'est pas le tableau typique. Ça arrive.

Le sac ovulaire extra-utérin avec activité cardiaque, c'est une GU jusqu'à preuve du contraire, on fait une échocytoscopie. Parfois vous avez fait votre échographie et vous avez trouvé que l'utérus est vide. Il n'y a pas d'image à côté, il n'y a rien.

L'échographie est normale. Si le taux de beta-ACG est inférieur à 1000, hospitalisez la femme, attendez 48 heures, refaites le dosage de beta-ACG, refaites l'échographie, et vous aurez la réponse, si c'est une GU ou non. Voilà une image, ici, vous voyez, c'est au centre, c'est le pseudo-sac gestationnel.

La même chose, c'est du sang, c'est un pseudo-sac gestationnel. Ici, vous avez la cavité de l'utérus, et vous avez ici un petit sac, et vous avez une couronne, vous ne voyez pas bien, je pense, de là-bas, mais vous voyez que, regardez la ligne de vacuité, elle est là, et le sac gestationnel est là, donc c'est à côté, c'est excentré, ça c'est pas le pseudo-sac, c'est le sac gestationnel. Voilà la ligne de vacuité, et là vous avez le sac gestationnel, et vous avez la couronne trophoblastique autour.

Ça c'est un sac gestationnel. Bon, tu as le diagnostic, deux choses, soit tu as le diagnostic, soit tu as une grossesse extra-utérine probable. Puisqu'elle peut se compliquer, elle peut entraîner la mort, donc je ne vais pas attendre.

Dans les deux cas, je dois traiter, ou au moins hospitaliser et surveiller. Donc le bilan à faire, un bilan pré-opératoire, parce que vous pouvez, à n'importe quel moment, opérer la femme, groupe à sanguins, c'est une femme qui saigne ou qui va saigner, le rhesus, si le rhesus est négatif, demander la recherche d'A, l'utérine irrégulière, et une numération formule pour voir, surtout l'hémoglobine, on va en voir avec le médecin réanimateur anesthésiste, ou bien demander un bilan pré-thérapeutique lorsque vous envisagez un traitement médical, nous verrons quel traitement médical. Donc au total, le diagnostic repose sur un tripied, la clinique, l'échographie,

les bêtas ASG.

S'il y a toujours un doute, malgré ce tripied, faites une celluloscopie. La celluloscopie, vous voyez, vous ne pouvez pas ne pas voir une ASG. Voilà.

Ça, c'est l'eau verte, ça, c'est la trempe, et qui est remplie du son. Ça, c'est l'hématosalpinx. Et il y a même, au niveau du douglas, il y a du son.

Voilà l'utérus, le voilà ici. Voilà du son dans le douglas, ça, c'est l'utérus, ça, c'est l'eau verte, et regardez ici, l'hématosalpinx. Les formes cliniques, plusieurs formes cliniques, la forme symptomatique, les formes symptomatiques, c'est plusieurs formes.

Il y a la forme pseudo-abortive, pseudo-abortive, c'est une forme clinique de la grossesse extra-utérine, mais les métroradius sont abondants et ils sont rougeâtres comme un avortement. C'est l'avortement de la caduque, l'élimination de la caduque, ce que je vous ai expliqué. L'endomètre qui va s'épaissir, etc.

Donc, je vous ai dit également que devant tout événement gynécologique, c'est une femme en période d'activité génitale, vous demandez les bêtas ASG. Et si vous demandez les bêtas ASG, vous allez voir, dans l'avortement, après l'avortement, les bêtas ASG diminuent rapidement parce que la grossesse est éliminée. Par contre, dans la grossesse extra-utérine, elle reste, elle n'est pas encore éliminée.

Il y a toujours le trophoblaste. Donc, vous pouvez dire que ce n'est pas un avortement, c'est autre chose. Il y a également, si vous êtes intelligent, vous prenez le produit, si vous avez de la chance également, vous aurez le produit de l'avortement entre guillemets, de ce qui a été éliminé.

Si vous l'envoyez à l'anatome pathologique, il ne va pas voir de dévilosité coréale. Il y a le signe histologique du trophoblaste parce que c'est l'acaduque, ce n'est pas le trophoblaste. Donc, le matériel éliminé, il n'y a pas de signe de grossesse.

Ça, c'est la forme pseudo-abortive. Il y a également la forme fébrile. C'est une grossesse extra-utérine avec une fièvre, parfois même à 39.

Vous allez penser beaucoup plus à la salpingite que la grossesse extra-utérine. Encore une fois, demandez les bêtas SG et ils vont venir positifs. Il y a la forme possy-symptomatique.

C'est ce que j'ai dit à M. Goulcombe. Peut-être qu'il n'y a pas de météorogie, il n'y a que de la douleur, il n'y a que les météorologies. Une forme avec un seul symptôme.

Donc, vous avez du mal à penser à la grossesse extra-utérine. Mais le problème est réglé si vous demandez un taux de bêtas SG chez une femme en période d'activité génitale qui a un problème gynécologique, tout simplement. Donc, les formes possy-symptomatiques, c'est les formes qui sont les plus trompeuses parce que vous allez prendre ça à la légère et la grossesse va évoluer

et elle peut se rompre en prenant ce qu'on appelle l'inondation péritoniale.

Il y a l'association grossesse intra-utérine, grossesse extra-utérine, je viens de parler de ça. Si vous n'avez pas de chance de gérer ce genre de patient, moi, personnellement, j'ai jamais eu de la chance de voir une femme qui a une grossesse intra-utérine avec une grossesse extra-utérine. Et il y a la grossesse hétérotopique, c'est-à-dire deux grossesses au niveau de 2,3.

En général, c'est dans la fécondation in vitro qu'on a ce genre de problème. La PMA, c'est la procréation médicalement assistée. Les formes évolutives, ça, c'est important.

Si tu ne fais pas le diagnostic, si tu ne traites pas à temps la grossesse extra-utérine, tu vas avoir des problèmes. La première, c'est l'inondation péritoniale. Ça veut dire quoi, l'inondation péritoniale ? Ça veut dire l'éclatement de la trompe.

Il va s'éclater. En général, c'est la grossesse ismique ou interstitielle ou grossesse cornuelle. Il se rend, il y a l'arrachement des vaisseaux et ils vont inonder l'abdomen du sang, parfois deux litres, un litre et demi de sang.

La femme va venir en état de choc avec des signes d'épongement péritonial. En général, comment on règle le problème ? Avec une échographie, on a du liquide dans l'abdomen. Du liquide, faites une pension et vous aurez le diagnostic, vous aurez du sang.

S'il y a du sang, il faut opérer. C'est une GU à 100 %, mais il faut également qu'il y ait de la réanimation parce que la femme peut mourir. Donc perfusion, transfusion, groupage, etc.

C'est en urgence, on fait tout en même temps. Il y a l'hématocèle. L'hématocèle, c'est quoi ? C'est un avortement tubo-abdominal.

Avortement de la trompe, de la grossesse qui va être avorté dans l'abdomen. La région la plus déclive chez la femme comme chez l'homme, c'est le douglas. Donc il va tomber au niveau du douglas.

Il va continuer à saigner, mais saigner doucement. C'est un saignement chronique. Ce saignement va entourer l'embryon au niveau du douglas.

Il va s'organiser parce qu'il va cailloter et il va donner une forme d'une tumeur. C'est comme une pseudo-tumeur au niveau du douglas. Le douglas, c'est ce qu'on appelle l'hématocèle rétro-utérine.

Derrière l'utérus. A l'examen, vous allez trouver une masse qui comble le douglas. Vous avez une femme qui a une altération de l'état général parce qu'elle saigne toujours.

Elle a des douleurs. Elle a un ténisme. Elle a des signes qui n'ont rien à voir avec la grossesse extra-utérine.

Des signes compressifs, une masse comblant le douglas, une anémie, des douleurs abdominales. Le malheur, c'est que c'est chronique. Ça fait longtemps que ça s'est arrivé.

C'est une GU qui s'est arrêtée depuis longtemps. Même si vous demandez le VETA-CG, ils vont revenir négatifs parce que la grossesse n'est plus active. En général, ce sont des femmes qu'on opère pour une masse rétro-utérine d'origine X. C'est l'anapathe qui va nous répondre qu'il s'agit d'un embryon avec deux ou trois voblasques.

C'est rare quand même. Maintenant, ça commence à être rare. On ne voit plus ces complications.

Il y a l'involution. C'est une grossesse extra-utérine qui va s'arrêter et qui va régresser. Elle va disparaître seule.

C'est ce qu'on appelle l'involution de la grossesse extra-utérine. C'est à peu près la saint-naissance d'un embryon. Vous savez qu'avant trois mois, vous dites qu'il y a une grossesse constituée de deux embryons.

Vous ne dites pas qu'il y a une grossesse gemellaire parce que parfois un embryon arrête d'évoluer et il disparaît. Il y a une grossesse gemellaire où il y a deux embryons et il disparaît. Moi, j'ai vécu ça plusieurs fois.

La disparition d'un embryon. Ça s'appelle la lise embryonnaire. Il disparaît.

C'est à peu près la même chose. Dans l'évolution, c'était la base d'un moyen thérapeutique qu'on appelle l'abstention thérapeutique en cas de grossesse extra-utérine. On ne peut rien faire.

On surveille jusqu'à la négativation de bêta-ACG, mais il faut surveiller. Voilà les objectifs de traitement. Il faut assurer l'hémostase.

Il faut supprimer la grossesse extra-utérine. C'est important de préserver la fertilité. Vous devez toujours penser à ce que la femme aurait besoin d'enfants après.

Il faut limiter les risques de récurrence, bien que c'est très difficile. Il faut limiter la morbidité thérapeutique. Le traitement doit être en mesure de prévenir la morbidité thérapeutique.

Surtout le traitement invasif par stériscopie ou par un moyen thérapeutique médical. Voilà les méthodes thérapeutiques. La première méthode, les moyens thérapeutiques, c'est l'abstention.

J'ai dit abstention plus surveillance. Cette abstention thérapeutique ne se conçoit qu'en milieu hospitalier. La base de ce moyen thérapeutique, c'est les cas qui subissent une évolution de la grossesse extra-utérine.

On va voir les indications. Si vous optez pour l'abstention thérapeutique, il faut hospitaliser la

femme et surveiller la femme cliniquement par échographie et par taux de bêta-ACG. Deuxième type, deuxième moyen thérapeutique, c'est la chirurgie.

Actuellement, la chirurgie ne se conçoit que par stériscopie. On n'opère pas, on ne fait pas de laparotomie pour traiter la grossesse extra-utérine, sauf dans quelques cas. Par exemple, si l'extrême urgence, la femme présente un état hémodynamique instable, un état de choc hémorragique, un hémopéritoïde important qui ne va pas nous permettre de faire une stériscopie, c'est dans ces cas qu'on doit faire une laparotomie.

La stériscopie, c'est surtout la stériochirurgie, exceptionnellement la laparotomie. Le traitement doit être le plus souvent conservateur, sauf dans quelques cas. Je vais les citer après.

Conservateur, c'est-à-dire conserver la trempe, bien entendu. Radical, ça veut dire enlever la trempe. On va voir.

Et il y a le traitement médical, l'abstention thérapeutique, le traitement chirurgical et le traitement médical. Le traitement médical, c'est à base de méthotrexate. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut faire un bilan préthérapeutique.

Si vous envisagez de traiter par le méthotrexate, donc il faut faire un bilan hépatique, un bilan hématologique, en vue de voir la toxicité du médicament. C'est vrai que ce n'est pas une dose extraordinaire, c'est un milligramme kilo. Une femme de 60 kilos, c'est 60 milligrammes.

En général, 60, on n'arrive pas à la toxicité du médicament de méthotrexate. Les services d'oncologie, c'est dans les 200 milligrammes, 200 et même plus. Par sélioscopie, on le fait rarement maintenant, mais on peut le faire.

Mais c'est surtout, par voie générale, l'injection intramusculaire. Une seule injection de méthotrexate, un milligramme kilo, on injecte, on fait un contrôle de bêta-CSG 48 heures plus tard pour voir si le traitement est efficace ou non. S'il est efficace, c'est-à-dire qu'il y a chute de bêta-CSG, c'est bon.

S'il n'y a pas de chute ou une chute légère, vous ajoutez une autre injection. Et c'est tout. S'il y a un, on parle d'échec de traitement médical et on fait la sélioscopie.

On peut aller éternellement. Ces deux injections. En général, les bêta-CSG disparaissent un mois.

Mais pas ascensionnelle au début. Parce que lorsque tu injectes, C'est des détails, mais c'est important. Tu injectes le méthotrexate.

48 heures plus tard, si tu fais les bêta-CSG 24 heures après l'injection, tu as une ascension de bêta-CSG. Pourquoi ? Parce que c'est le trophoblast qui est en train de se nécroser et libère ce qui est là, le reste de bêta-CSG. Donc tu vas trouver un taux qui est sensiblement plus important

que l'autre.

Donc il ne faut pas s'affoler, il faut attendre. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut attendre 48 heures pour faire une injection pour éviter de l'ascension. Le taux de bêta-CSG, vous allez trouver une ascension.

Ça ne veut pas dire que le traitement est inefficace. Ça veut dire que vous êtes dans la phase ascensionnelle de début de méthotrexate. Ne vous affolez pas si vous avez ça.

On a commencé maintenant, c'est bien pour les gynécologues qui sont affectés ailleurs, on communique par WhatsApp, par Messenger, par n'importe quoi, pour des cas qui posent des problèmes. Le traitement robotique, le centre le meilleur d'Avakin, Strasbourg. Donc les indications, le traitement médical, comment on commence ? Je simplifie, nous commençons ça et vous allez voir pourquoi.

Le traitement médical, si la grossesse extra-utérine est peu évolutive, qu'est-ce que ça veut dire peu évolutive ? Tout simplement, ça veut dire que tu as un taux de bêta-CSG inférieur à 5000. Tu es sûr que c'est une GU, c'est-à-dire bêta-CSG, et qu'au graphéon confirmé le diagnostic, c'est une grossesse extra-utérine où il n'y a pas d'embryons avec activité cardiaque positive et si tu as la possibilité de surveiller, ça veut dire qu'il faut traiter à l'intérieur de l'hôpital. Donc une grossesse qui est peu évolutive, taux de bêta-CSG inférieur à 5000, un embryon avec activité cardiaque négative et il n'y a pas de dépanchement dans le douglas et la surveillance est possible.

Ça, vous traitez médicalement, c'est-à-dire par la méthode TREXA. Vous allez trouver dans les bouquins ou dans les articles qu'actuellement, peut-être bêta-CSG inférieur à 10000 ou 8000, je trouve que c'est dangereux, sauf si tu peux traiter à la minute après que tu traites chirurgicalement. Si tu as la capacité de traiter à la minute une femme, tu peux traiter médicalement une femme de 8000 unités ou 10 000 unités.

Dès que ça ne va pas bien, vous transférez au bloc et vous opérez. Mais un danger reste toujours. Vous allez trouver ça.

Vous allez trouver également qu'il y en a qui parlent, la grossesse non embryonnée, il n'y a pas d'embryon. Mais actuellement, c'est l'embryon avec activité cardiaque positive. Si c'est négatif, il peut disparaître.

Lui aussi. Ça, c'est le traitement médical. Attention, une femme qui a une grossesse extra-utérine et qui a un résus négatif peut suivre une comment on les appelle une halo-immunisation, donc obligatoirement donner le sérum anti-D à la femme.

Si il y a un résus négatif, vous n'aurez pas la possibilité de faire un prélèvement sanguin du bébé, donc il va entraîner une halo-immunisation chez la maman. Donc, il vaut mieux donner un sérum

anti-D. C'est systématique.

La grossesse extra-utérine, l'avortement, la grossesse molaire. Les trois, tu fais un anti-D parce que tu n'as pas à savoir le groupage du bébé. L'abstention plus surveillance.

C'est lorsque la grossesse extra-utérine est inférieure à 1000 unités, mais à condition que la surveillance est possible en milieu hospitalier. Ça veut dire que si vous êtes dans un cabinet médical, vous n'avez pas le droit de traiter, vous pouvez proposer à l'équipe hospitalière un traitement médical, mais en intra-hospitalière. Donc, une grossesse évolutive précoce inférieure à 1000, ça c'est des grossesses extra-utérines qui peuvent disparaître.

Soit disparaître, soit 48 heures plus tard, au lieu d'avoir 1000, tu vas trouver 2000. Et dans ce cas, ça devient évolutif et tu vas tomber au niveau du traitement médical. Est-ce que vous avez compris? Donc voilà, ça c'est l'abstention thérapeutique.

Vous ne faites rien, vous allez surveiller. Soit il va disparaître, soit il va tomber dans les autres catégories de GUE. GUE, indication de traitement médical, ou GUE, indication de traitement chirurgical.

Comme on va voir, la chirurgie est indiquée en cas de grossesse extra-utérine évolutive, insénuément importante, ou bien une grossesse extra-utérine récidivante, c'est une femme qui a eu une GUE. Vous avez fait un traitement médical, deux ou trois ans plus tard, elle revient le même côté avec une grossesse extra-utérine. Vous n'avez pas le droit de faire un traitement conservateur parce que la treme est de mauvaise qualité.

Si vous la laissez, elle va retomber enceinte au niveau de la même treme. Donc le traitement chirurgical est indiqué en cas de grossesse extra-utérine évolutive, c'est-à-dire au-delà de 5000, des mille unités, il y a insénuément important, donc vous allez faire un traitement. Et la grossesse extra-utérine récidivante, la chirurgie est le traitement radical.

Quand on fait un traitement radical, ce n'est pas uniquement lorsque la GUE est récidivante. Vous écrivez. Le traitement radical, c'est la salpingectomie, c'est l'exérèse de toute la treme.

L'indication de la salpingectomie, la grossesse extra-utérine, c'est lorsque c'est une grossesse extra-utérine récidivante, la première. Deuxièmement, lorsque la femme est multipare, elle a beaucoup d'enfants vivants, si la femme a trois ou quatre enfants vivants, ça sert à quoi de laisser la treme ? La treme, on la laisse pour avoir des enfants. Il faut savoir qu'il y a toujours un risque de GUE.

Lorsque la femme n'a pas d'enfants, on est obligé de jouer le jeu et de surveiller, etc. Mais lorsque la femme a des enfants vivants, ce n'est pas la peine. C'est illusoire de laisser une treme chez une femme qui a des enfants.

Premièrement, GUE récidivante. Deuxièmement, quand j'ai eu la femme avec beaucoup

d'enfants vivants. Troisièmement, lorsqu'il y a un éclatement de la trompe, lorsque le traitement conservateur ne peut pas se faire, il y a un éclatement de toute la trompe, donc on ne peut pas refaire la trompe.

Dans ce cas, on fait une salpingectomie et lorsqu'on ne peut pas faire les moustaches, on fait le traitement conservateur, mais on n'arrive pas à contrôler les moustaches. Dans ce cas, on fait une salpingectomie. Voilà les quatre indications de traitement par salpingectomie.

Premièrement, la GUE récidivante. Deuxièmement, la femme multiplie par plusieurs enfants vivants. Troisièmement, lorsque le traitement ne peut pas se faire parce qu'il y a une mauvaise qualité de la trompe, elle est toute éclatée.

Quatrièmement, lorsqu'on ne peut pas faire une hémostase par traitement conservateur. Dans le reste des cas, si on fait un traitement sélioscopique, c'est un traitement conservateur pour le reste. Les autres coulombes, c'est le traitement conservateur.

Il y a des cas intermédiaires, des situations. Je peux multiplier les situations, on ne va pas s'arrêter. Dans ce cas, c'est en général la discussion thérapeutique où on prend la décision de ce qu'il faut faire.

Est-ce qu'il faut faire un traitement médical ? Est-ce qu'il faut faire un traitement chirurgical ? Est-ce qu'il faut faire un traitement chirurgical radical ? Un traitement chirurgical conservateur ? Ainsi de suite. Voilà un peu si vous faites un traitement chirurgical radical, c'est-à-dire que vous enlevez toute la trompe, la femme aura la possibilité d'avoir une grossesse intra-utérine par l'autre trompe dans 50% des cas. Mais également, elle peut avoir une grossesse extra-utérine contre-latérale dans 15% des cas.

C'est plus important que chez la femme normale qui n'a pas eu de GU. C'est après le traitement. Après le traitement radical.

Après le traitement conservateur, le taux de grossesse intra-utérine est de 60%. Donc c'est pas aussi important que lorsqu'on fait un traitement radical. Est-ce que vous avez vu ? Donc moralité, c'est que c'est beaucoup plus lorsque tu as une salpingectomie et d'un côté déjà faite, et la femme a fait une GU de l'autre côté, c'est là où tu as à choisir entre le traitement radical et le traitement conservateur.

Parce que même si tu fais une salpingectomie, l'autre trompe, si elle est normale, elle peut jouer le jeu facilement, on aura une grossesse intra-utérine. Ce qu'il faut faire, chaque fois que vous avez fait un traitement d'une grossesse intra-utérine, il faut toujours prévenir la patiente, parce que j'ai dit qu'il peut récidiver plus que les autres femmes. Donc toujours dire à la femme, attention, vous pouvez avoir une grossesse intra-utérine, donc dès que vous avez un retard de règles, dès que vous avez des météorologies, dès que vous avez des douleurs péloviennes, elle peut consulter.

Il faut consulter. Donc voilà, c'est ça. Est-ce que vous avez des questions ?